

Adénopathies

Dr N. BOULEKROUNE

Plan du cours

-  **Part 01 :**
 - Généralités**
 - Objectifs pédagogiques
 - Introduction/ Définition
 - Rappels : anatomique/ physiologique/ physiopathologique
-  **Part 02 :**
 - Démarche diagnostique**
 - Adénopathies superficielles
 - Adénopathies profondes
-  **Part 03 :**
 - Etiologies**
 - Adénopathies bénignes
 - Adénopathies malignes
-  **Part 04 :**
 - Conclusion**
 - Points à retenir
 - Références

Objectifs pédagogiques



1. Reconnaître une adénopathie.
2. Reconnaître par l'interrogatoire et l'examen physique, les caractéristiques cliniques d'une adénopathie superficielle.
3. Différencier par l'examen clinique, une adénopathie superficielle d'une tuméfaction non ganglionnaire dans la région axillaire, cervicale et inguinale.

I. Introduction/ Définition

- ✚ Les ganglions lymphatiques se sont :
 - Des organes lymphoïdes secondaires (ils drainent la lymphe d'un territoire anatomique).
 - Le siège de la première étape de la réaction immunitaire.
- ✚ Une adénopathie correspond à l'augmentation pathologique du volume d'un ganglion lymphatique ;
 - Qui devient palpable cliniquement ou visible à l'imagerie.
 - Et dont le diamètre du ganglion est supérieur 1.5 cm on territoire inguinal et 1.0 cm dans les autres territoires.
- ✚ Le diagnostic positif d'adénopathie est souvent aisé, se pose alors le problème du diagnostic étiologique.
- ✚ La démarche diagnostique devant une adénopathie repose une approche clinique structurée et un panel simple d'examens complémentaires.
- ✚ La recherche étiologique des adénopathies repose essentiellement sur ces caractéristiques cliniques, qu'il s'agisse :
 - Superficielles ou profondes
 - Symptomatiques ou non
 - Uniques ou multiples
 - Aigues ou chroniques.

II. Rappels

A) Anatomique :

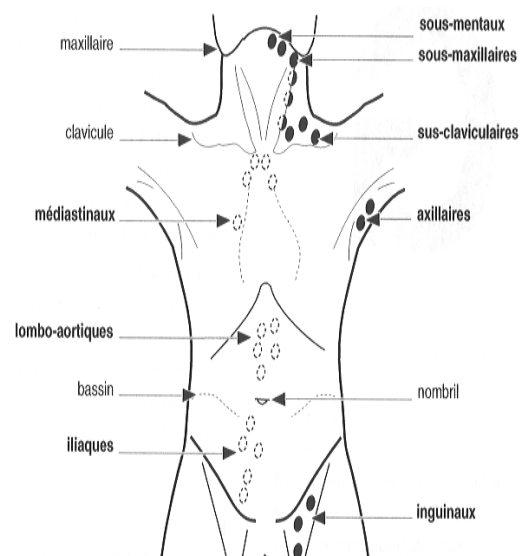
➤ Anatomie ganglionnaire :

- ✚ Les ganglions sont des formations nodulaires dispersées le long des voies lymphatiques. Ils sont regroupés dans plusieurs territoires superficiels (cervicaux, axillaires, inguinaux, etc.) et profonds (médiastinaux, mésentériques, etc.).
- ✚ Ce sont des nodules réniformes, entourés d'une capsule fibreuse, qui mesurent de façon physiologique moins d'un centimètre de diamètre.
- ✚ La coupe d'un ganglion montre deux secteurs, l'un périphérique occupé par des structures nodulaires dites « folliculaires », l'autre central constitué par le cordon médullaire.



➤ Principales aires ganglionnaires

principales aires ganglionnaires	
superficielles	profondes
- cervicales : sous-maxillaires jugulo-carotidiennes spinales, trapéziennes - sus-claviculaires - axillaires - inguinales (Scarpa, rétrocrurales) - épitrochléennes, poplitées	- médiastinales : latérotrachéales, interbronchiques péribronchiques - abdominales : rétropéritonéales mésentériques - pelviennes : iliaques internes iliaques externes



B) Physiologique :

Les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes secondaires, ils ont pour fonction :

- La filtration de la lymphe grâce à l'activité phagocytaire des macrophages qui vont phagocyter les particules apportées par la lymphe telles que les bactéries, les substances étrangères ou les débris...
- Initiation de la réponse immunitaire, activation et prolifération des lymphocytes B et T aboutissant à une réponse humorale et cellulaire.

C) **Physiopathologie** : l'augmentation du volume d'un ganglion lymphatique peut être consécutive à ;

- Une réaction lymphocytaire ou macrophagique à une stimulation antigénique locorégionale ou générale.
- Une prolifération tumorale primitive du tissu lymphoïde.
- Un envahissement par des cellules malignes non lymphoïdes.

III. Démarche diagnostique

A) Adénopathies superficielles :

A-1) Circonstances de découverte :

✚ Découverte fortuite :

- Par le patient lui-même par la vue et/ou le toucher (dans la grande majorité des cas).
- Lors d'un examen clinique systématique des aires ganglionnaires.
- Ou lors de la réalisation d'un examen radiologique.

✚ Devant des signes d'appel :

- Douleur localisée de l'adénopathie.
- Signes généraux : sueurs nocturnes, prurit, fièvre, amaigrissement...etc

✚ Plus rarement, lors d'une complication.

A-2) Interrogatoire : il permet d'orienter le diagnostic et précise :

✚ L'âge du patient :

- Chez l'enfant, les pathologies inflammatoires ou infectieuses sont plus fréquentes.
- Chez un sujet jeune : une adénopathie d'allure maligne oriente plutôt vers une hémopathie maligne.
- Et chez le sujet de plus de 50 ans : vers un cancer.

✚ Les antécédents médicaux et chirurgicaux, notamment :

- L'existence d'une maladie de système connue, cancer, lymphome, maladie vénérienne, exérèse d'un nævus, infection ORL, etc.
- D'une intervention chirurgicale cervico-faciale ou du cuir chevelu.
- D'une tuberculose ou d'une primo-infection tuberculeuse.

✚ La nature des traitements médicamenteux et soins dentaires encourus, les vaccinations récentes.

✚ La date de découverte/d'apparition de l'adénopathie :

- Caractère unique ou multiple.
- Mode d'apparition et son évolution spontanée ou sous l'effet d'un traitement.
- Douleur ou non.
- Taille : stable ou augmentation progressive de la taille.

✚ Le Mode de vie :

- Intoxication alcool-tabagique.
- Exposition aux animaux (contact avec chat, chien, oiseau, poisson).

✚ Le statut vaccinal, notamment vis-à-vis de la tuberculose et des maladies éruptives (rougeole-oreillons-rubéole [ROR]...).

✚ La notion d'un contagé récent ou ancien (tuberculose, contact avec des enfants).

✚ Les signes fonctionnels ORL associés : dysphagie, odynophagie, dysphonie, dyspnée laryngée, otalgie, épistaxis, obstruction nasale, surdité.

- ✚ Les signes généraux : altération de l'état général, fièvre, sueurs nocturnes, frissons, prurit (en précisant sa chronologie par rapport à l'apparition des adénopathies).

A-3) Examen physique : comporte plusieurs volets.

❖ Inspection : permettra

- ✚ De déceler la présence d'une tuméfaction (l'augmentation d'un ou plusieurs ganglions se manifestant par une masse de volume et de forme variables).
- ✚ Préciser le siège.
- ✚ Rechercher une porte d'entrée dans la zone de drainage exp : bucco-dentaire, griffure de chat.
- ✚ Lorsque les ganglions sont volumineux, ils soulèvent alors la peau en regard.
- ✚ La peau recouvrant l'adénopathie peut être normale rouge inflammatoire, amincie, ulcérée ou fistulisée.

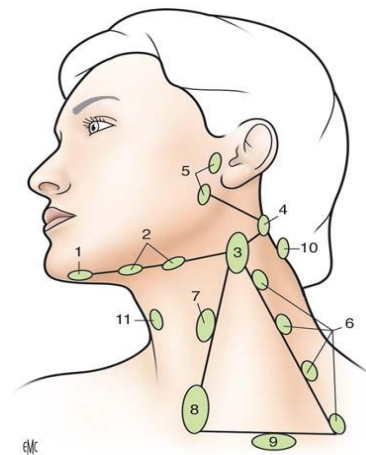
❖ Palpation : toutes les aires ganglionnaires doivent être explorées, quelle que soit la présentation initiale.

- ✚ Il faut préciser leurs différents caractères et débiter par les aires ganglionnaires situées au niveau de la tête, puis le cou, les membres supérieurs et inférieurs, et terminer par la région poplitée.
- ✚ Elle doit être pratiquée en faisant relâcher les muscles qui recouvrent la région observée.
- ✚ Le patient est d'abord examiné assis au bord du lit afin de palper les aires ganglionnaires cervicales et axillaires (le médecin se plaçant dans le dos du sujet), puis couché pour l'abord des aires ganglionnaires inguinales et pour l'appréciation du syndrome tumoral profond (notamment la recherche d'une hépatomégalie ou splénomégalie).

1. Examen des aires ganglionnaires :

a. Aires cervicales :

- ✚ Face à l'examineur, la tête doit être légèrement penchée en avant et tournée vers le côté à examiner afin de relâcher les muscles du cou.
- ✚ Il existe plusieurs groupements ganglionnaires :
 - Ganglions pré auriculaires et parotidiens (4) : drainent les conjonctives, cuir chevelu, parotides, oreille moyenne.
 - Ganglions sous-occipitaux (10) : drainent le cuir chevelu, nasopharynx.
 - Ganglions maxillaires : drainent les lèvres inférieures, joues, langue, plancher du massif facial.
 - Ganglions mentonniers (1) : drainent les lèvres, gencives.
 - Ganglions jugulo-carotidiens (7/8) : drainent la voile du palais, pharynx, larynx et amygdales.



b. Aires sus-claviculaires :

- ✚ Elle se trouve dans l'angle formé par la clavicule et le muscle le sterno-cléido-mastoïdien.
- ✚ L'examineur est derrière le patient, les doigts recourbés en crochet dans le creux sus-claviculaire.

✚ Les ganglions drainent :

- A droite : œsophage, thyroïde, poumon droit, sein droit et la moitié inférieure du poumon gauche.
- A gauche : thyroïde gauche, sein gauche, moitié supérieure du poumon gauche, tube digestif.

Les adénopathies gauches réalisent le ganglion de **Troisier** ce qui doit faire évoquer un cancer digestif.

c. Aires axillaires :

- ✚ Sujet couché ou assis, le bras repose sur la main gauche de l'examineur, la main droite est introduite jusqu'au sommet de la pyramide axillaire.
- ✚ Cette aire draine le sein, la paroi thoracique, les membres supérieurs et la paroi abdominale.

d. Aires épitrochléennes :

- ✚ Sur un sujet au coude fléchi, l'examineur palpe la gouttière située entre le biceps et le triceps, environ 3 cm au-dessus de l'épitrochlée, les doigts recourbés en crochet.
- ✚ Elle draine la partie cubitale de la main.

e. Aires inguinales :

- ✚ En décubitus dorsal, les cuisses en extension, on palpe au-dessus, sur le pli inguinal et sur la face antéro-interne de la cuisse.

✚ Deux groupes :

- Groupement horizontal : situé au-dessous de l'arcade crurale, draine la paroi abdominale inférieure, les organes génitaux externes, région fessière et l'anus.
- Groupement vertical : situé sur la face antéro-interne de la cuisse, draine les membres inférieurs.

f. Aires poplitées :

- Creux poplité, jambe demi fléchie.
- Ils drainent le talon, la face externe du pied et la partie profonde de la jambe.

2. Nombre de territoires :

- ✚ Atteinte isolée (localisée) : atteinte d'une seule aire ganglionnaire ou de plusieurs territoires correspondant à une même zone de drainage (atteinte unilatérale).
- ✚ Elle peut multiple : mais dans ce cas, elle se situe du même côté du diaphragme (plusieurs territoires ganglionnaires atteints pour des zones de drainage différentes).
- ✚ Atteinte généralisée : 2 ou plusieurs aires ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme.
- ✚ L'atteinte isolée correspond le plus souvent à une pathologie locorégionale, tandis que l'atteinte multiple indique une maladie générale.

3. Caractéristiques des adénopathies :

- ✚ Taille et consistance :
 - La taille est donnée en Centimètre.
 - Consistance : ferme, souple ou dure (en faveur d'un cancer).
- ✚ Sensibilité : existence ou non d'une douleur à la palpation ou non.
- ✚ Mobilité : par rapport aux ganglions entre eux et par rapport au plan superficiel et au plan profond.
- ✚ Le siège exact.
- ✚ Le caractère isolé ou multiple.

 Ces critères sont notés sur un schéma daté.

4. Pièges diagnostiques :

- ✚ Les adénopathies non pathologiques :
 - De petite taille (diamètre inférieur à 1 cm).
 - Le volume de l'adénopathie ne doit pas augmenter (surveillance renforcée).
 - De consistance souple ou ferme (mais jamais dure).
 - Mobiles et indolores, sans signes inflammatoires.
 - Le bilan clinique et biologique (numération formule sanguine, vitesse de sédimentation) doit être normal.
- ✚ En dehors de toute pathologie évolutive, on peut palper :
 - Adénopathies inguinales.
 - Adénopathies axillaires chez les travailleurs manuels.
- ✚ Cependant, toute adénopathie sus-claviculaire doit être considérée comme pathologique chez l'adulte.

A-4) Eliminer ce qui n'est pas un ganglion :

- ❖ Région cervicale : les tuméfactions multiples et latérales sont souvent des adénopathies. Si elles sont uniques ou médianes, d'autres diagnostics sont possibles :
 - Lipomes et nodules sous cutanés.
 - Hypertrophie des glandes salivaires (en regard de la parotide ou de la glande sous-maxillaire).
 - Goitre ou nodule thyroïdien (mobile avec la déglutition).
 - Anévrysme carotidien.
 - Kyste du tractus thyroïdien.
- ❖ Région axillaire :
 - Hidrosadénite, à écarter facilement car il s'agit d'une infection d'une glande sébacée, caractérisée par une tuméfaction rouge douloureuse, superficielle et adhérente à la peau.
 - Abscessus.
- ❖ Région inguinale : hernie inguinale, anévrysme artériel, ectopie testiculaire, lipomes.

A-5) Examens complémentaires :

- L'échographie cervicale est surtout utile si l'on hésite entre le diagnostic d'une tumeur primitive ou d'une adénopathie cervicale. Cet examen rapide, facile, non invasif et reproductible permet également d'explorer les glandes thyroïde, parotide et sous-maxillaire et de guider une éventuelle ponction à l'aiguille fine à visée cytologique.
- Bilan complémentaire initial minimal d'adénopathie(s) sans cause locale évidente :
 - ✚ Examens biologiques :
 - Numération formule sanguine avec plaquettes.
 - VS, C-reactive protein (CRP) : à la recherche d'un syndrome inflammatoire.
 - IDR à la tuberculine.
 - Sérologies : toxoplasmose, primo-infection EBV, VIH, syphilis.
 - Électrophorèse des protéines sanguines, transaminases, LDH.
 - ✚ Imagerie : scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien chez l'adulte.
 - ✚ Analyse directe de l'adénopathie : **ponction ganglionnaire** (à discuter), peu invasive (réalisée au lit du patient) mais de faible sensibilité, permet un ;
 - Examen cytologique : cellules anormales.
 - Examen cytopathologique direct.
 - Cultures sur milieux appropriés (bactériologie, mycobactéries, voire champignons).
 - Biopsie ganglionnaire : confirmer le diagnostic.

B) Adénopathies profondes

B-1) Adénopathies médiastinales :

- ✚ Il s'agit généralement d'une découverte lors d'un examen radiologique :
 - Sur le thorax par un élargissement du médiastin ou des images para-hilaires.
 - Lors d'une TDM thoracique.
- ✚ Lorsqu'elles sont volumineuses, elles s'expriment par :
 - Un syndrome de compression de la veine cave supérieure (œdème en pèlerine, circulation veineuse thoracique superficielle, téguments rosés basithoraciques).
 - Dyspnée (par compression).

B-2) Adénopathies abdominales :

- ✚ Intra-péritonéales : elles sont souvent découvertes lors d'une échographie.
- ✚ Rétropéritonéales : découvertes par des signes de compression :
 - Lymphatique ou veineuse : œdèmes des membres inférieurs.
 - Pyélo-urétérale responsable d'une anurie.

IV. Etiologies

A) Adénopathies bénignes :

A-1) Adénopathies localisées :

Elles sont souvent satellites d'une infection de voisinage : des caries dentaires, des foyers ORL, des abcès du sein, des infections de la main ou du pied, ou encore de la tuberculose...

A-1) Adénopathies généralisées :

Evoquer une infection virale, une brucellose (fièvre, arthralgies, sueurs nocturnes, prise de lait cru) ainsi que des septicémies bactériennes ou fongiques.

B) Adénopathies malignes :

B-1) Cancers :

Infiltration des ganglions par des cellules cancéreuses provenant d'un cancer de voisinage ou à distance. Il s'agit d'adénopathies fermes ou dures fixées au plan profond.

B-2) Hémopathies :

- ✚ Leucémie aigues : adénopathies souvent cervicales, anémie, hémorragie, splénomégalie. Le diagnostic est fait par la présence de cellules blastiques dans le sang et la moelle.
- ✚ Leucémie lymphoïde chronique : touche des sujets âgés et se manifeste par une lymphocytose sanguine et médullaire.
- ✚ Lymphomes : adénopathie localisée cervicale basse, fièvre et prurit, le diagnostic est posé par biopsie.

V. Points à retenir :

- ✚ Il s'agit d'une situation clinique fréquente.
- ✚ Le diagnostic est le plus souvent facile.
- ✚ Chaque aire ganglionnaire draine un territoire précis.
- ✚ L'aspect et le siège peuvent servir d'éléments d'orientation clinique.
- ✚ Les adénopathies sont d'étiologies diverses : elles peuvent être la traduction d'une affection bénigne (inflammatoire ou infectieuse) ou maligne (primitive ou secondaire).
- ✚ Il n'existe aucun signe sémiologique formel permettant d'affirmer qu'une adénopathie est bénigne.

❖ Référence :

- 1] Béatrix Barry. Adénopathie cervicale de l'adulte. La revue du praticien médecine générale l tome 32 l n° 1002 l mai 2018
- 2] Papo T. Adénopathie superficielle. EMC - Traité de Médecine Akos 2020;23(2):1-5 [Article 1-0180].
- 3] Truong Tan Trung T., Tankéré F. Adénopathie cervicale : conduite à tenir. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Traité de Médecine Akos, 6-0490, 2010.
- 4] Vigué MG.et al. Diagnostic des adénopathies superficielles de l'enfant. EMC - Pédiatrie 2018;13(1):1-7 [Article 4-082-j-10].